

Transición epidemiológica y envejecimiento poblacional

1. Introducción y relevancia en Salud Pública y en el EUNACOM

La **transición epidemiológica** es el proceso mediante el cual las causas predominantes de enfermedad y muerte en una población cambian desde enfermedades transmisibles, maternas e infantiles hacia **enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT)** y condiciones degenerativas asociadas a la edad.

Chile atraviesa una **etapa avanzada de este proceso**, marcada por una disminución de la natalidad y mortalidad infantil, junto a un incremento sostenido de la **esperanza de vida** y de la **proporción de adultos mayores**.

En el **EUNACOM**, este tema tiene alta relevancia porque articula conocimientos de **epidemiología, salud pública, salud familiar y políticas sanitarias**, permitiendo al médico general comprender:

- La dinámica de las enfermedades a lo largo del tiempo.
- Las implicancias de la longevidad en la organización del sistema de salud.
- La importancia de la promoción y prevención en el envejecimiento saludable.

2. Conceptos fundamentales y marco conceptual

2.1. Transición demográfica

Proceso paralelo y complementario a la transición epidemiológica.

Implica el paso de:

1. Alta natalidad y mortalidad → crecimiento poblacional lento.
2. Descenso de la mortalidad → aumento del crecimiento poblacional.
3. Descenso de la natalidad → estabilización y envejecimiento poblacional.

Resultado: aumento de la proporción de adultos mayores y reducción de niños y jóvenes.

2.2. Transición epidemiológica (Omran, 1971)

Omran describió tres grandes fases históricas:

Etapa	Características	Ejemplo
1. Edad de pestes y hambrunas	Alta mortalidad, baja esperanza de vida, predominio de infecciones y desnutrición.	Siglo XIX.
2. Edad de pandemias en retroceso	Mejora del saneamiento, descenso de infecciones, aumento de enfermedades crónicas.	Chile: 1930–1970.
3. Edad de enfermedades degenerativas y crónicas	Predominio de ECNT, envejecimiento poblacional y muertes por causas cardiovasculares, cáncer y metabólicas.	Chile: desde 1990 hasta hoy.

Etapas actual en Chile: avanzada, con coexistencia de ECNT y desafíos de salud mental, envejecimiento y multimorbilidad.

2.3. Envejecimiento poblacional

“Proceso de incremento sostenido de la proporción de personas mayores (≥60 o ≥65 años) dentro del total de la población.”
(OMS, 2021)

El envejecimiento es consecuencia directa del éxito sanitario: menor mortalidad y fecundidad, y mayor esperanza de vida.

En Chile, se considera “población envejecida” cuando **el porcentaje de personas ≥65 años supera el 10 %** del total.

3. Situación epidemiológica y demográfica de Chile (2024)

3.1. Indicadores clave

Indicador	1990	2010	2024 (estimado)	Fuente
Esperanza de vida (años)	74	79	81,1	DEIS-INE
Tasa de natalidad (por 1.000)	22	15	9,1	INE
Tasa de fecundidad (hijos/mujer)	2,6	1,9	1,5	DEIS
Población ≥65 años (%)	6,5	10,2	13,5	INE
Índice de envejecimiento	30	53	76	INE 2024

Interpretación: Chile ha completado una transición demográfica avanzada, similar a países europeos, con un crecimiento lento y envejecimiento progresivo.

3.2. Perfil epidemiológico actual

Las principales **causas de muerte (DEIS 2023)** son:

1. Enfermedades cardiovasculares (26,3 %).
2. Tumores malignos (24,5 %).
3. Enfermedades respiratorias crónicas (9,2 %).
4. Diabetes mellitus (6,1 %).
5. Enfermedades del sistema nervioso (demencias, Alzheimer).

Las **enfermedades infecciosas**, que en 1950 representaban más del 40 % de las muertes, hoy no superan el 5 %.

3.3. Desafíos emergentes

- Aumento de **multimorbilidad** y dependencia funcional.
 - Creciente prevalencia de **demencias y depresión en el adulto mayor**.
 - Mayores costos en atención de salud y medicamentos.
 - Necesidad de redes de cuidados de largo plazo y atención domiciliaria.
 - Reaparición de brotes infecciosos (COVID-19, virus respiratorios) que afectan más gravemente a los mayores.
-

4. Determinantes del envejecimiento poblacional

1. **Descenso sostenido de la fecundidad:** menos nacimientos → menor base juvenil.
 2. **Reducción de la mortalidad:** avances sanitarios, vacunación, control de enfermedades crónicas.
 3. **Mejoras socioeconómicas:** educación, nutrición y vivienda.
 4. **Migración internacional:** llegada de población joven extranjera mitiga parcialmente el envejecimiento.
 5. **Avances en salud pública:** programas de APS, vacunación, control prenatal y cobertura universal.
-

5. Consecuencias sociales y sanitarias del envejecimiento

Dimensión	Impacto principal
Epidemiológica	Aumento de ECNT, discapacidad y dependencia.
Sanitaria	Mayor demanda de servicios de salud y fármacos.

Económica Presión sobre sistemas previsionales y de cuidados.

Familiar y social Necesidad de redes de apoyo intergeneracional.

Política pública Enfoque en envejecimiento activo y prevención de dependencia.

6. Normativa y estrategias ministeriales vigentes

Programa / Política	Institución responsable	Objetivo
Estrategia Nacional de Salud 2021–2030	MINSAL	Reducir brechas de esperanza de vida y dependencia funcional.
Política Nacional de Envejecimiento Positivo (2017–2030)	SENAMA– MINSAL	Fomentar envejecimiento activo, autonomía y participación.
Programa Más Adultos Mayores Autovalentes (APS)	MINSAL	Promoción de la funcionalidad y autocuidado.
Ley N.º 21.168 (2019)	Congreso Nacional	Reconoce los derechos de las personas mayores.
Programa de Cuidados Domiciliarios y Comunitarios	SENAMA	Atención integral a adultos mayores dependientes.

7. Modelo de intervención y estrategias de acción

7.1. Enfoque de prevención por niveles

Nivel	Objetivo	Ejemplo de acción
Primaria	Prevenir enfermedades y promover envejecimiento saludable.	Promoción de actividad física, alimentación saludable, vacunación antigripal.
Secundaria	Detectar precozmente enfermedades crónicas.	Pesquisa de hipertensión, diabetes, dislipidemia.
Terciaria	Reducir discapacidad y dependencia.	Rehabilitación, control de multimorbilidad, atención domiciliaria.

7.2. Estrategias intersectoriales

- Integración de servicios sanitarios y sociales.
 - Fortalecimiento de la red APS con enfoque gerontológico.
 - Programas de acompañamiento comunitario (p. ej., “Más Adultos Mayores Autovalentes”).
 - Coordinación con SENAMA, municipalidades y organizaciones comunitarias.
-

7.3. Vigilancia y monitoreo

- Indicadores de funcionalidad (EFAM, Barthel, Lawton-Brody).
 - Registro Nacional del Adulto Mayor en APS.
 - Indicadores de dependencia y mortalidad en mayores de 65 años.
-

8. Rol del médico general y competencias en APS

Función	Ejemplo de competencia
Detección precoz	Pesquisar fragilidad y deterioro cognitivo.
Prevención y promoción	Implementar talleres de envejecimiento activo, vacunación y control de factores de riesgo.
Educación familiar	Fomentar redes de apoyo y cuidado del cuidador.
Gestión comunitaria	Integrar programas SENAMA, CHCC adulto mayor, clubes y organizaciones sociales.
Vigilancia epidemiológica	Analizar indicadores locales de morbilidad y dependencia.

El médico de APS es el **agente clave** para mantener la autonomía funcional y prevenir la dependencia en la vejez.

9. Errores comunes en EUNACOM

Error	Corrección
Confundir transición demográfica con epidemiológica	La primera describe cambios poblacionales; la segunda, cambios en causas de enfermedad y muerte.
Asociar envejecimiento con enfermedad	Envejecer no es sinónimo de enfermar; el objetivo es un envejecimiento saludable.

Creer que la mortalidad por ECNT indica fracaso del sistema

Es un resultado natural del aumento de la longevidad.

No considerar las diferencias de género

Las mujeres viven más, pero con mayor morbilidad crónica.

Ignorar la función social del médico en APS

La gestión comunitaria es tan importante como la atención clínica.

10. Complicaciones y pronóstico

- Incremento sostenido de **dependencia funcional** (proyección: 25 % de los mayores en 2050).
- **Demencia y Alzheimer** como causas principales de discapacidad.
- Mayor **demandas de cuidados paliativos y domiciliarios**.
- Desafíos en sostenibilidad del sistema de salud y pensiones.

Pronóstico nacional:

Si se mantienen las tendencias actuales, Chile alcanzará un **20 % de población ≥65 años hacia 2050**, consolidando un perfil de **país envejecido**, lo que requerirá reorganizar su sistema sanitario hacia la **gerontología comunitaria**.

11. Referencias ministeriales y técnicas

- MINSAL (2024). Estrategia Nacional de Salud 2021–2030.
- INE (2024). Proyecciones y estimaciones de población.
- DEIS (2023). Estadísticas Vitales.
- OPS/OMS (2022). Envejecimiento saludable: marco de acción 2021–2030.

- SENAMA–MINSAL. Política Nacional de Envejecimiento Positivo.
-

12. Resumen final — 5–7 ideas clave

1. Chile se encuentra en una **etapa avanzada de transición epidemiológica**, dominada por ECNT y envejecimiento poblacional.
2. La **esperanza de vida supera los 81 años**, con fecundidad baja y natalidad en descenso.
3. El **13,5 % de la población** tiene 65 años o más, con tendencia al aumento.
4. Las principales causas de muerte son **cardiovasculares y cáncer**, reflejo del cambio epidemiológico.
5. El **envejecimiento** genera desafíos en dependencia, gasto sanitario y red de cuidados.
6. El **médico de APS** debe promover envejecimiento activo, prevención de discapacidad y participación comunitaria.
7. Las políticas actuales buscan un **enfoque integral e intersectorial** de salud y bienestar en la vejez.